

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

INVENTARIO BREVE DE DOLOR (BPI - SHORT FORM)

Brief Pain Inventory (Cleeland & Ryan, 1994) · Validación Española (Badía et al., 2003) · MD Anderson Cancer Center

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Inventario Breve de Dolor - Forma Corta (Brief Pain Inventory - Short Form, BPI-SF)
Sigla / Acrónimo	BPI (en español denominado frecuentemente CBD - Cuestionario Breve del Dolor)
Autoría original	Charles S. Cleeland (Department of Symptom Research, MD Anderson Cancer Center, 1991, 1994)
Adaptación en español	Badía, Muriel, Gracia et al. (2003, Med Clin / Aten Primaria)
Constructo evaluado	Intensidad del dolor y grado de interferencia en las actividades cotidianas vitales
Población diana	Adultos con dolor crónico oncológico, musculoesquelético, neuropático o postquirúrgico
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (autoadministrado o mediante entrevista clínica asistida)
Estructura y formato	Mapa corporal anatómico, 4 ítems de intensidad (0-10) y 7 ítems de interferencia funcional (0-10)
Condiciones de uso	Gratuito para práctica clínica e investigación no comercial previa solicitud a MD Anderson

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El dolor crónico es una experiencia sensorial y emocional desagradable multidimensional que trasciende la nocicepción tisular pura. Siguiendo el modelo biopsicosocial y las directrices de la **Iniciativa sobre Métodos, Mediciones y Evaluación del Dolor en Ensayos Clínicos** (IMMPACT), la gravedad clínica del dolor no puede medirse únicamente por su intensidad nociceptiva, sino por el grado de interferencia o disfunción reactiva que causa en la vida afectiva, física y relacional del individuo.

El BPI fue desarrollado originalmente en el contexto oncológico por Cleeland y rápidamente extendido a todo tipo de dolor persistente no oncológico. Permite evaluar simultáneamente la dimensión sensorial (intensidad peor, menor, promedio y actual) y la dimensión reactiva/funcional (impacto en la marcha, trabajo, estado de ánimo, relaciones, sueño y disfrute), además de monitorizar el porcentaje de alivio percibido atribuible a las intervenciones terapéuticas.

3. ESTRUCTURA DE DIMENSIONES E ÍTEMS DEL BPI-SF

Dimensión	Ítems Origen	Escala	Contenido y Operacionalización Clínica
Topografía del Dolor	Diagrama somático	Cualitativo	Localización anatómica del dolor primario y zonas de irradiación
Intensidad Sensorial	Ítems 3, 4, 5, 6	0 a 10 (NRS)	Dolor en su punto máximo, mínimo, media habitual y dolor ahora
Alivio Terapéutico	Ítem 8	0% a 100%	Porcentaje subjetivo de alivio aportado por los tratamientos recibidos
Interferencia Funcional	Ítems 9A a 9G	0 a 10 (NRS)	Impacto en: Actividad general, Estado de ánimo, Capacidad de caminar, Trabajo habitual, Relaciones con personas, Sueño y Disfrute de la vida

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA Y ONCOLÓGICA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad; subescala de Intensidad $\alpha = 0.87 - 0.89$; subescala de Interferencia $\alpha = 0.89 - 0.92$ en la validación de Badia et al. (2003).
Estabilidad temporal	Test-retest a 7-14 días con CCI = 0.80 para intensidad y 0.85 para interferencia en pacientes estables.
Validez de constructo	Análisis factorial confirmatorio ratifica consistentemente la solución de dos factores interrelacionados: Intensidad del Dolor e Interferencia Reactiva.
Validez convergente	Correlación significativa con la Escala Analógica Visual (EVA, $r = 0.84$), subescalas de dolor corporal del SF-36 ($r = -0.73$) y Karnofsky Performance Status ($r = -0.56$).
Sensibilidad al cambio	Capacidad demostrada para captar mejoría tras analgesia escalonada de la OMS; una reducción de 2 puntos o 30% representa una diferencia clínica mínima importante (MCID).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal evaluado	Los ítems se refieren formalmente a las últimas 24 horas (o a la última semana en dolor crónico no oncológico).
Índice de Intensidad	Media aritmética de los 4 ítems de gravedad (peor, menor, media y actual): " Intensidad Media " = $(I3 + I4 + I5 + I6) / 4$. Rango: 0 a 10 .
Índice de Interferencia	Media aritmética de los 7 ítems funcionales: " Interferencia Media " = $(9A + 9B + 9C + 9D + 9E + 9F + 9G) / 7$. Rango: 0 a 10 .
Subdimensiones analíticas	Opcionalmente se puede desagregar la interferencia en: Dimensión Física (actividad, caminar, trabajo) y Dimensión Afectiva (ánimo, relaciones, sueño, disfrute).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación (0-10)	Percentil Aprox.	Estrato de Gravedad	Implicación Clínica y Calidad de Vida
1 - 3 puntos	< Pc 40	Dolor Leve	Baja interferencia en actividades. Controlable con analgesia de primer escalón.
4 - 6 puntos	Pc 45 - Pc 75	Dolor Moderado	Interferencia manifiesta en trabajo y descanso. Precisa opioides menores o coadyuvantes.
7 - 10 puntos	> Pc 80	Dolor Severo / Incapacitante	Parálisis funcional severa; alteración afectiva profunda. Opioides potentes.

PUNTOS DE CORTE CRÍTICOS (IMPACT / OMS):

- **Intensidad "Peor Dolor" ≥ 7 :** Umbral de dolor severo que exige revisión analgésica prioritaria en menos de 24-48 horas.
- **Interferencia > 5 :** Refleja impacto discapacitante en la autonomía personal; requiere intervención multimodal (fisioterapia, psicología del dolor y rehabilitación).

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN MANEJO DEL DOLOR

Paso 1: Medición basal: Obtener puntuaciones de Intensidad Media e Interferencia Media.

Paso 2: Si Intensidad 1 — 3 (Leve): Mantener pauta analgésica periférica (AINEs, paracetamol) y medidas físicas conservadoras.

Paso 3: Si Intensidad 4 — 6 (Moderado): Escalar a segundo escalón OMS (tramadol, codeína) o neuromoduladores (pregabalina, duloxetina si hay componente neuropático).

Paso 4: Si Intensidad 7 — 10 (Severo): Escalar a opioides mayores (morfina, oxycodona, fentanilo, tapentadol) con rescates pautados.

Paso 5: Si Interferencia Desproporcionada a la Intensidad: (ej. Intensidad = 3 pero Interferencia = 8): Sospechar comorbilidad psicopatológica (depresión comórbida, catastrofismo elevado o trastorno de adaptación); derivar a Psicooncología / Salud Mental.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN UNIDAD DE DOLOR

Identificación: Paciente varón de 59 años con cáncer colorrectal metastásico óseo en columna lumbosacra, remitido a Cuidados Paliativos y Unidad de Dolor por dolor irruptivo mal controlado.

Evaluación Inicial BPI:

- Intensidad Sensorial: Peor = 9/10; Menor = 4/10; Promedio = 7/10; Actual = 8/10 (**Media de Intensidad = 7.0 / 10**). Alivio con paracetamol/codeína = 20%.
- Interferencia Funcional: Actividad = 9, Ánimo = 8, Marcha = 9, Trabajo = 10, Relaciones = 6, Sueño = 8, Disfrute = 9 (**Media de Interferencia = 8.4 / 10**).

Ajuste Terapéutico: Rotación a fentanilo transdérmico ($50 \frac{\text{mcg}}{\text{h}}$) más fentanilo sublingual para crisis de dolor irruptivo (200 mcg), pautándose además pregabalina 75 mg/12h por componente radicular compresivo.

Reevaluación a las 3 semanas: La Media de Intensidad se redujo a **2.5 / 10** (descenso de 4.5 puntos, mejoría > 60%), el Alivio aumentó al 85% y la Media de Interferencia cayó a **3.1 / 10**, restableciéndose el descanso nocturno continuo y la movilidad domiciliaria.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas en Dolor:

- Compresión Medular Aguda:** Dolor axial severo asociado a paresia de miembros inferiores o incontinencia de esfínteres (urgencia quirúrgica).
- Dolor Refractario Agudo:** Empeoramiento súbito del dolor en metástasis óseas exige descartar fractura patológica inminente.

Diagnóstico Diferencial:

- Dolor Nociceptivo vs. Neuropático:** El BPI detecta interferencia; si hay alodinia, quemazón o hiperalgesia aplicar DN4 o LANSS.
- Dolor Total:** Concepto de Saunders donde el sufrimiento existencial amplifica la percepción física del dolor nociceptivo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Badia, X., Muriel, C., Gracia, A., Núñez-Olarte, J. M., Perulero, N., Gálvez, R., Carulla, J., & Cleeland, C. S. (2003). Validación de la versión española del Cuestionario Breve del Dolor en pacientes con dolor oncológico. *Medicina Clínica*, 120(2), 52-59. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(03\)73601-4](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(03)73601-4)
- Cleeland, C. S., & Ryan, K. M. (1994). Pain assessment: global use of the Brief Pain Inventory. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 23(2), 129-138.
- Dworkin, R. H., Turk, D. C., Farrar, J. T., Haythornthwaite, J. A., et al. (2005). Core outcome measures for chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. *Pain*, 113(1-2), 9-19.
- Caraceni, A., Cherny, N., Fainsinger, R., Kaasa, S., Poulain, P., Radbruch, L., & De Conno, F. (2002). Pain measurement tools and methods in clinical research in palliative care: recommendations of an Expert Working Group of the EAPC. *Journal of Pain and Symptom Management*, 23(3), 239-255.